

Question 60: Prééclampsie

Evaluation 2025

Dr Khaled Trigui

1. La prééclampsie s'accompagne de:

A. Augmentation des résistances vasculaires utérines

B. Hyperperméabilité vasculaire maternelle

C. Stress oxydatif trophoblastique

D. Diminution de la libération du VEGF

E. Hémolyse intra vasculaire

2. L'hypertension artérielle gravidique :

- A. Évolue vers une prééclampsie en absence de traitement
- B. Fait suite à une ischémie placentaire
- C. Peut apparaître avant 20 SA
- D. Se complique d'un retard de croissance intra-utérin en cas de survenue précoce
- E. Est un facteur de risque de prééclampsie

3. Une douleur épigastrique chez une femme présentant une prééclampsie peut être en rapport avec:

A. Une HELLP syndrome

B. Un signe prodrome d'une crise d'éclampsie

C. Un hématome sous capsulaire de foie

D. Un hématome rétro placentaire

E. Une cytolysé hépatique importante

4. L'hématome rétro placentaire:

A. Est une complication imprévisible

B. Peut être précédée par des signes prodromes

C. Peut simuler une urgence chirurgicale

D. Les anomalies du rythme cardiaque fœtal sont la circonstance de découverte la plus fréquente

E. Peut survenir sur un placenta prævia

5. L'insuffisance rénale aiguë au cours d'une prééclampsie sévère:

A. Est un signe de gravité

B. Impose une évacuation fœtale immédiate

C. Est associée à une diurèse conservée

D. Contre indique la prescription du sulfate de magnésium

E. Est définie par une créatinémie $>90 \mu\text{mol/l}$

6. Une extraction fœtale en urgence pour RCIU dans un contexte de prééclampsie est indiquée:

A. Anomalie du rythme cardiaque fœtal

B. Altération du doppler veineux fœtal

C. Un oligoamnios modéré

D. Un indice de résistance élevé au doppler ombilical

E. Une biométrie fœtale <5^{ème} percentile

7. Le HELLP syndrome comporte les anomalies biologiques suivantes:

A. Une anémie arégénérative

B. Une cytolysé hépatique

C. Une chute de l'haptoglobine

D. La présence de schizocytes au frottis sanguin

E. Une thrombopénie

8. Le traitement anti-hypertenseur chez une femme enceinte à 33SA présentant une prééclampsie

- A. Peut prévenir certaines complications viscérales
- B. Est une source de souffrance fœtale quand il dépasse les objectifs thérapeutiques
- C. Est administré par voie intraveineuse en présence de signes de gravité
- D. Est contre indiqué en cas d'anurie maternelle
- E. N'a pas d'indication dans la prééclampsie légère

9. Une extraction après une maturation pulmonaire foetale par corticothérapie est indiquée:

A. HELLP syndrome

B. Hématome rétro placentaire

C. RCIU sévère

D. Crise d'éclampsie

E. Œdème aigu du poumon

10.Devant une prééclampsie modérée à 35 SA, vous indiquez:

- A. Une hospitalisation jusqu'à accouchement
- B. Une maturation pulmonaire fœtale
- C. Un antihypertenseur par voie orale
- D. Une surveillance biologique quotidienne
- E. Un accouchement à partir de 36SA

11. La prise en charge d'une crise d'éclampsie comporte:

- A. Une intubation et ventilation en cas d'échec du traitement anti convulsivant
- B. La prescription d'un antihypertenseur par voie orale
- C. La prescription du sulfate magnésium par voie intraveineuse
- D. L'extraction fœtale après réanimation maternelle
- E. La restriction du remplissage vasculaire

12. Le dépistage de la prééclampsie :

- A. Se fait au début du 2^{ème} trimestre
- B. Inclut la mesure de l'indice de pulsatilité des artères utérines
- C. Aide à la prévention des complications de la prééclampsie
- D. Est recommandé chez toute femme enceinte
- E. Permet de poser l'indication de la prescription de l'aspirine

CAS CLINIQUE 1

Une femme âgée de 22 ans, primipare, consulte pour des céphalées intenses et un flou visuel à un terme 30 semaines d'aménorrhée (SA).

L'examen à l'admission trouve une tension artérielle à 170/100 mm hg et une protéinurie à la bandelette réactive à trois croix.

La patiente rapporte une diminution des mouvements actifs fœtaux.

1. Parmi les critères suivants, ceux qui sont en rapport avec une prééclampsie sévère :

A. Une tension artérielle à 170/100 mm hg

B. Une protéinurie à la bandelette réactive à trois croix

C. Des céphalées intenses

D. Un flou visuel

E. Une diminution des mouvements actifs fœtaux

2. La prise en charge thérapeutique symptomatique pour prévenir les complications de la prééclampsie sévère chez cette patiente comporte :

- A. Une perfusion de Sulfate de magnésium
- B. Un Inhibiteur calcique par voie intra veineuse
- C. Une bithérapie antihypertensive par voie orale
- D. Des antalgiques
- E. Une héparine de bas poids moléculaire

3. La complication la plus redoutée dans ce contexte clinique est:

A. Un hématome rétro placentaire

B. Un HELLP syndrome

C. Une crise d'éclampsie

D. Une insuffisance rénale aigue

E. Une hémorragie méningée

4. Les explorations à demander chez cette patiente devant la prééclampsie sévère :

A. Une imagerie cérébrale

B. Une protéinurie de 24 heures

C. Un dosage de l'uricémie

D. Un enregistrement du rythme cardiaque fœtal

E. Un bilan d'hémostase

5. Le bilan de retentissement materno-fœtal est sans anomalie, la conduite à tenir obstétricale sera :

A. Une expectative jusqu'à 34 SA

B. Un déclenchement du travail à 32 SA

C. Un déclenchement du travail à 30 SA

D. Une césarienne en urgence

E. Une césarienne après maturation pulmonaire fœtale

Cas clinique 2

Une femme enceinte à 26 SA, adressée pour des chiffres tensionnels à 145/95 mm hg et une protéinurie de 24h de 200mg. Le reste de l'examen est sans anomalie. Les mouvements actifs fœtaux sont présents.

1. Votre conduite initiale sera:

A. Une échographie obstétricale

B. Un bilan biologique de prééclampsie

C. Une nouvelle mesure des chiffres tensionnels

D. Un ECBU

E. Un enregistrement du rythme cardiaque fœtal

2. Les explorations ne montrent pas d'anomalie, la prise en charge thérapeutique pour cette femme comporte:

- A. Une hospitalisation
- B. Une surveillance en ambulatoire
- C. Une maturation pulmonaire fœtale
- D. Un antihypertenseur
- E. Une prescription de l'aspirine

3. À 28 SA, la patiente présente des douleurs pelviennes légères, la tension artérielle à 165/100mm hg, l'examen clinique devant ce contexte, doit rechercher les signes pathologiques suivants:

A. Des reflexes ostéotendineux abolis

B. Des râles crépitants

C. Un œdème du visage

D. Une hauteur utérine augmentée

E. Des ecchymoses cutanées

4. La patiente signale une douleur abdominale intense et brutale, le diagnostic d'un hématome rétro placentaire est suspecté:
- A. La patiente doit être acheminée au bloc opératoire
 - B. Une échographie sera faite pour évaluer la vitalité fœtale
 - C. Une maturation pulmonaire fœtale sera prescrite en urgence
 - D. La césarienne est la voie d'accouchement recommandée
 - E. Le sulfate de magnésium est indiqué pour diminuer le risque d'une crise d'éclampsie associée

5. La prise en charge en post partum de cette femme comporte:

A. Une protéinurie de 24 h à 3 mois après l'accouchement

B. Un bilan de thrombophilie

C. La mise sous traitement antihypertenseur pendant une durée minimale de 1 mois

D. Une contraception par pilule oestroprogestative

E. Une prescription d'aspirine lors de la grossesse ultérieure